

MANITAPIA

Γενικά: Σπάνιες θεωρούνται πλέον οι δηλητηριάσεις από βρώσημανιταριών στην Ελλάδα. Τα κατ' εξοχήν θανατηφόρα είδη στην Ευρώπη, είναι τα ακόλουθα: *Amanita muscaria*, *Amanita phalloides*, *Clitocybe rivulosa*, *Gyromitra esculenta* και *Pleurocybella porrigens*.

Η δηλητηρίαση, με τα κλινικά επακόλουθα, οφείλεται σε μίγμα διαφόρων τοξινών, όπως η μουσκαρίνη, η φαλλοειδίνη, η φαλλοϊνη, οι α-, β- και γ- αματοξίνες, η αμανιτολυσίνη, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Εμφανίζεται με **συμπτωματολογία από το πεπτικό**, εντός 2-6 ωρών από τη βρώση και περιλαμβάνει γενική αδιαθεσία, ναυτία και εμέτους, διαρροϊκές κενώσεις, επίσης με **συμπτώματα από το ΚΝΣ**, όπως αιμωδία ή άλγος στα άκρα, τρόμο, σπασμούς, εφίδρωση, μύση, διεγερτική κατάσταση παρόμοια με μανία και τέλος, μετά από πάροδο αρκετών ωρών, με **συμπτώματα από το Ήπαρ** (6-48 h), όπως επιγαστραλγία, ναυτία με δύσσομους εμέτους, ίκτερο, κολικούς, δύσσομες και αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις, τεινεσμός, οξέωση, σήψη κ.ά. Καθυστερημένα, μπορεί να εμφανισθεί **οξεία νεφρική βλάβη ή οξύ αιμολυτικό σύνδρομο**, με νεφροπάθεια, ανουρία, ουραιμία, αιμόλυση, αιμοσφαιρινουρία, σπασμούς, ενίοτε κώμα.

Έχει παρατηρηθεί ότι όσο μεγαλύτερος - μετά τη βρώση των μανιταριών - είναι ο χρόνος εμφάνισης των αρχικών συμπτωμάτων, τόσο βαρύτερη είναι η μορφή της δηλητηρίασης.

Διαφορική διάγνωση: Θα γίνει από την οξεία ηπατική και νεφρική βλάβη, το ηπατονεφρικό σύνδρομο, τη λοιμώδη γαστρεντερίτιδα, την οξεία ηπατίτιδα, την ηπατική εγκεφαλοπάθεια, το σηπτικό shock, την τοξίκωση από Παρακεταμόλη, Οργανοφωσφορικά, Ισονιαζίδη, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πρώτο μέλημα είναι η **πρόκληση εμέτου** με τη χορήγηση Απομορφίνης (amp. Apo-Go 10 mg, sc) ή εναλλακτικά με χορήγηση σιροπιού Ιπεκακουάνας 2 g (ήτοι 2 fl. των 15 ml).
2. Ακολουθεί γαστρική έκπλυση – μέσω σωλήνα Levin – με ταννικό οξύ ή υπερμαγγανικό κάλιο (*προαιρετικά*) και εν συνεχεία εκπλύσεις στομάχου με φυσιολογικό ορό NaCl 0,9%.
3. Χορηγούνται per os 50 gr **ενεργού άνθρακα** (1 fl. Toxicarb των 250 ml) κάθε 2-4 ώρες, καθώς και **αλατούχα καθαρτικά** (3-5 sachets *Molaxole* 13,7 gr ή *Fortrans* 74 gr, per os).
4. Τοποθετούμε 3-way φλεβική γραμμή και χορηγούμε 1000 ml N/S ή 1000 ml D/W 5%.
5. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley 14-16 fr, για τη μέτρηση του ισοζυγίου υγρών.
6. Χορηγούμε υψηλές δόσεις **Πενικιλίνης G**, (*Benzylpenicillin*) ήτοι: 5×10^6 IU/6ωρο (ή σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση), διότι έχει ευεργετική επίδραση, καθώς εκτοπίζει τις τοξίνες των μανιταριών από την λευκοματίνη του πλάσματος και έτσι αυτές αποδεσμεύονται και καθίστανται λιγότερο τοξικές για τα κύτταρα και μπορούν να αποβληθούν με τα ούρα.
7. Μεγάλη σημασία, επίσης, έχει η **πρώιμη διούρηση**, ώστε να αποβληθούν οι τοξίνες των μανιταριών, άμεσα και προτού συνδεθούν με τη λευκοματίνη του πλάσματος, διαδικασία που θεωρείται ότι συμβαίνει μέσα στις πρώτες 36 ώρες από τη βρώση των μανιταριών. Έτσι, χορηγούμε Φουροσεμίδα, 3-6 amp. *Lasix* σε 500-1000 ml N/S, σε συνεχή στάγδην ενδοφλέβια έγχυση, ιδιαίτερα κατά το πρώτο 24ωρο της θεραπείας της τοξίκωσης.
8. Επί παρουσίας μουσκαρινικών συμπτωμάτων (*βραδυκαρδία, μύση, εφίδρωση, σιελόρροια, δακρύρροια, βρογχόσπασμος, κ.ά.*), χορηγούμε 1-2 mg (1-2 amp.) **Ατροπίνης** (iv ή im) και επαναλαμβάνεται η χορήγηση μέχρι εμφάνισης μυδρίασης ή ξηροστομίας (*Ατροπινισμός*).
9. Σε περίπτωση τοξίκωσης από Φαλλοειδίνη (*Amanita phalloides*) χορηγείται ενδοφλεβίως **Σιλμπινίνη** (*Legalon/Madaus*) 4 fl. (δόση: 20 mg/kg/24h) σε 2ωρη έγχυση, διαιρεμένα σε 4 δόσεις, για το πρώτο 24ωρο· ως ηπατοπροστατευτικό φάρμακο και όχι ως αντίδοτο.
10. Λόγω εκπτώσεως της ηπατικής λειτουργίας και επί εμφάνισης σοβαρών διαταραχών της πήξεως, χορηγούμε ενδομυϊκώς 5-10 mg Φυτομεναδιόνης (vit. K₁: ½-1 amp. *Konakion*).
11. Επί σπασμών ή διεγέρσεως, χορηγούμε 1 amp. Διαζεπάμης (*Stedon*) 10 mg, εντός 100 ml NaCl 0,9%, βραδέως ενδοφλεβίως κι επικουρικά Πυριδοξίνη (B6 - *Becilan*) 25 mg/kg ΒΣ.
12. Διακομίζουμε τον ασθενή, άμεσα, στο νοσοκομείο, για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.